

Ingestión de cuerpo extraño

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Normas H. Notti 2015 – Consenso de Urgencias endoscópicas 2016

1- ABC

Clínica con estridor laríngeo, disnea, tiraje supraclavicular y/o intercostal constituye una urgencia médica que obliga a realizar la endoscopia inmediatamente.

2- Radiografía: cuello, tórax y abdomen (frente y perfil)

3- Localización

A- Esófago

- Segmento superior (más frecuente, debido al paso de músculo esquelético a liso)
- Segmento medio (donde se localiza el arco aórtico)

Tipo

- Corto punzante/pila (Provocan en pocas horas corrosión y necrosis por licuefacción): endoscopia inmediata
- Romo: Derivación a centro de mayor complejidad para realizar endoscopia antes de las 24 hs. Ayuno, control clínico y Rx en 6 hs. (mientras esperamos el ayuno es posible que avance y no requiera endoscopia)

B- Estómago

- > de 2 cm de diámetro o 5 cm de longitud: extracción
- Cortopunzante-Pila: Derivación a centro de mayor complejidad para realizar endoscopia antes de las 24 hs. Ayuno, control clínico y Rx en 6 hs. (mientras esperamos el ayuno es posible que avance y no requiera endoscopia)
- Romo: Rx 6-12-24 hs: sin avance se realiza endoscopia en 36-48hs

C- Intestino

- Corto punzante/pila: Se considera que, si la pila pasó el píloro, no es una urgencia extraerla, sino que se debe hacer seguimiento radiológico, ya que son pocos los casos de lesión intestinal u obstrucción por ellas.
Rx c/3 días, sin avance se realiza cirugía a cielo abierto o enteroscopia.
- Romo: Rx c/10 días, sin avance se realiza cirugía a cielo abierto o enteroscopia.

Pautas de alarma que nos orientan a la extracción inmediata: vómitos, distensión abdominal, fiebre, disminución de peso

Imanes: cuando está adherido a otro objeto metálico o imán puede producir necrosis por compresión, esto debe sospecharse siempre, por lo que se hospitaliza para observación.

Complicaciones de la VEDA (videoendoscopia digestiva alta)

Erosión, sangrado, úlcera, hematoma, perforación

Después de la extracción de la pila, el niño debe ser observado por posibles complicaciones, como fístula traqueoesofágica, otras perforaciones de esófago, parálisis de cuerdas vocales por lesión del nervio recurrente, mediastinitis, neumotórax, neumoperitoneo, traqueomalacia, neumonía por aspiración. La causa más común de muerte es la fístula aortoesofágica, que puede ocurrir hasta varios días después de la remoción.

Perforación

El diagnóstico se realiza sobre la base del antecedente, la existencia de dolor cervical, odinofagia, disfagia, crepitación, celulitis o, en casos más avanzados, un paciente séptico, con cuello tumefacto y fluctuante.

Como métodos de diagnóstico, la radiografía simple de cuello lateral muestra la presencia de aire prevertebral.

La TAC se indicará en casos de sospecha clínica de perforación cuando no se pudo comprobar por otros métodos.